

ORIGINAL



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1201

INFORME NEGATIVO

17 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 1201**, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

 El **Proyecto del Senado 1201** propone añadir un Capítulo 5 de la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguro de Salud de Puerto Rico", a fin de garantizar que todos los planes médicos públicos y privados incluyan cobertura para terapias con células madre debidamente aprobadas por las autoridades regulatorias, además de establecer parámetros para su autorización, fiscalización y acceso equitativo; enmendar el Artículo III de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", para añadir nuevos incisos (h), (i), (j), (ff), (mm), (nn) y (oo), redesignar los actuales incisos (h) al (j) como incisos (k) al (m), los actuales incisos (k) al (bb) como incisos (n) al (ee), y los actuales incisos (cc) al (hh) como incisos (gg) al (ll), y redesignar los incisos subsiguientes según corresponda; y añadir un inciso (g) del subinciso (1) del inciso "Cubierta C" de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de establecer que todo plan de salud en Puerto Rico, incluyendo el Plan Vital, provea cobertura para tratamientos con células madre, y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, la medicina regenerativa se ha consolidado como una de las áreas más prometedoras de la práctica clínica contemporánea, particularmente por su potencial terapéutico en condiciones complejas. Los tratamientos basados en el uso de células madre adultas han demostrado eficacia en una amplia gama de afecciones hematológicas, inmunológicas, oncológicas y degenerativas. Tal como expone la *Food and Drug Administration* (FDA), más de setenta condiciones han sido tratadas mediante terapias basadas en células madre, muchas de ellas aprobadas y aplicadas en Puerto Rico a través de centros especializados, como el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.



A pesar de este progreso, miles de pacientes en la Isla enfrentan barreras económicas severas para acceder a estas terapias porque los planes médicos no están obligados a cubrirlas, aun cuando se trate de usos clínicos aprobados y no experimentales. Esto provoca desigualdad en el acceso al tratamiento, limita la práctica médica basada en evidencia y genera un retraso en comparación con jurisdicciones de Estados Unidos, tales como los estados de Texas y Florida, donde se han adelantado políticas que buscan promover tratamientos seguros y regulados.

El autor de la medida resaltó la urgencia de establecer un marco que no solo regule el uso de células madre, sino que también garantice el acceso real a tratamientos clínicos aprobados, evitando que su alto costo excluya a los pacientes que más los necesitan. Es Considera, que un mandato de cobertura uniforme para todos los planes médicos ampliaría las opciones terapéuticas, fomentaría el desarrollo de la medicina avanzada y garantizaría la equidad en el acceso a tratamientos que pueden ser vitales para la calidad de vida de la gente.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa propuso se establezca una cobertura obligatoria de tratamientos clínicos con células madre bajo criterios médicos claros, estándares regulatorios, supervisión adecuada y salvaguardas éticas.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del P. del S. 1201, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: Departamento de Salud, la Oficina del Procurador

del Paciente (OPP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (ACODESE), el Plan de Salud Menonita, Inc. (PSM), MMM Holdings, LLC, la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Asociación Médica de Puerto Rico, al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), First Medical Health Plan, Inc., MCS Foundation, y Triple-S Salud, Inc.; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias, entidades y ciudadanos consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El **Departamento de Salud** compareció ante la Comisión de Salud, por conducto de Secretario, Dr. Víctor Ramos Otero, para expresar su posición en contra del Proyecto del Senado 1201, medida que propone garantizar la cobertura de terapias con células madre debidamente aprobadas por las autoridades regulatorias en todos los planes médicos públicos y privados, incluyendo el Plan Vital. En el ejercicio de su responsabilidad constitucional de velar por la salud pública y promover el acceso a servicios de salud de excelencia, el Departamento reconoció la importancia de continuar evaluando alternativas terapéuticas innovadoras que puedan beneficiar a pacientes con condiciones complejas y mejorar la calidad de los servicios médicos disponibles en Puerto Rico.

En ese sentido, la Agencia destacó que la pieza legislativa persigue ampliar el acceso a tratamientos de medicina regenerativa, particularmente aquellos relacionados con terapias celulares y génicas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Asimismo, señaló que la medida procura incorporar como cubierta esencial diversos servicios asociados a estas terapias,

incluyendo trasplantes de células madre hematopoyéticas, procedimientos regenerativos, hospitalización, procesamiento celular, medicamentos especializados y demás servicios complementarios requeridos para la prestación integral de dichos tratamientos.

De igual forma, explicó que la propuesta legislativa incorpora importantes protecciones para los pacientes al prohibir discrímenes por condiciones preexistentes, edad o condición socioeconómica, y al limitar la imposición de copagos o deducibles más onerosos que aquellos aplicables a otros tratamientos complejos. Además, observó que la medida excluye expresamente procedimientos de naturaleza cosmética, terapias sin aprobación regulatoria y determinados usos de células madre embrionarias, procurando así establecer parámetros mínimos de seguridad y cumplimiento regulatorio.



No obstante, durante su evaluación, el Departamento consultó a la Administración de Seguros de Salud (ASES), la cual advirtió que cualquier modificación a los beneficios cubiertos bajo el Plan Vital que reciba financiamiento federal requiere la presentación y aprobación de una Enmienda al Plan Estatal (*State Plan Amendment* o SPA) ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Según indicó, este proceso exige una justificación programática detallada y un análisis exhaustivo del impacto fiscal de la medida antes de que pueda autorizarse su implantación.

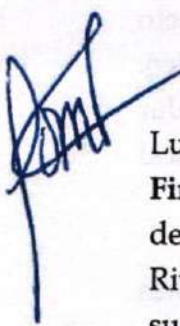
Asimismo, la Agencia resaltó que los costos asociados a las terapias de medicina regenerativa pueden variar significativamente dependiendo de la modalidad terapéutica utilizada. A esos efectos, señaló que algunos tratamientos pueden oscilar entre \$5,000 y \$50,000 por paciente, mientras que terapias más avanzadas, como los tratamientos CAR-T, pueden superar los dos millones de dólares. En consecuencia, advirtió que la ausencia de estimados presupuestarios precisos dificulta evaluar adecuadamente el impacto económico que tendría la expansión obligatoria de estas cubiertas sobre el sistema público de salud.

Por otro lado, destacó que el Plan Vital ya contempla determinadas terapias celulares y trasplantes hematopoyéticos para condiciones oncológicas y hematológicas específicas mediante la denominada "Cubierta Especial". Del mismo modo, señaló que los beneficiarios cuentan con el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediabiles (FSECR), mecanismo que permite financiar tratamientos vitales de alto costo cuando las circunstancias clínicas así lo ameritan. Además, puntualizó que las

únicas terapias expresamente excluidas son aquellas que permanecen en fase investigativa o que no cuentan con la aprobación de la FDA.

A pesar de reconocer el propósito encomiable de la medida, el Departamento concluyó que la amplitud de la redacción propuesta dificulta realizar proyecciones fiscales confiables y evaluar con precisión las consecuencias económicas de su implantación. Igualmente, señaló que la limitada disponibilidad de proveedores certificados en Puerto Rico y la necesidad de obtener aprobaciones regulatorias federales constituyen obstáculos significativos para la ejecución inmediata de la política pública propuesta. Por consiguiente, sostuvo que la medida carece actualmente de los elementos necesarios para garantizar una implantación viable y sostenible.

En virtud de los fundamentos expuestos, el Departamento de Salud indicó que no favorece el Proyecto del Senado 1201 en su redacción actual, aunque reiteró su disposición de colaborar en iniciativas dirigidas a ampliar el acceso a tratamientos médicos avanzados dentro de un marco clínico, regulatorio y fiscalmente responsable.



AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, la **Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)**, presentó su memorial explicativo por conducto de su Director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior, Lcdo. Luis R. Rivera Cruz, expresándose en contra de la aprobación de la medida. En el desempeño de sus funciones como principal asesor financiero y agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico, la AAFAF examinó la propuesta desde la perspectiva de su impacto fiscal, presupuestario y programático sobre las finanzas públicas y el cumplimiento de las disposiciones establecidas bajo la Ley PROMESA y el Plan Fiscal certificado.

Reconoció que la medida persigue un propósito legítimo y socialmente meritorio al procurar ampliar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras de medicina regenerativa. Asimismo, señaló que el Proyecto busca garantizar que los tratamientos con células madre aprobados por la FDA, así como los servicios asociados a dichos procedimientos, formen parte de las cubiertas de salud disponibles en Puerto Rico, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno. Además, observó que la propuesta limita la imposición de copagos, deducibles y otros costos compartidos excesivos, al tiempo que permite determinadas exclusiones relacionadas con procedimientos de carácter exclusivamente cosmético o estético.

No obstante, la AAFAF puntualizó que toda medida legislativa que pueda generar obligaciones económicas para el Gobierno de Puerto Rico debe evaluarse a la luz de los requisitos establecidos en la Sección 204 de la Ley PROMESA. A esos efectos, recordó que cualquier legislación con impacto fiscal potencial debe estar acompañada de un análisis detallado sobre sus efectos presupuestarios, económicos y financieros, así como de una identificación clara de las fuentes de financiamiento necesarias para sufragar los costos asociados a su implantación. Según indicó, este análisis resulta indispensable para garantizar que la medida sea compatible con el Plan Fiscal certificado y con el presupuesto balanceado exigido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

De igual forma, advirtió que del expediente legislativo no surge evidencia de que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) haya realizado el análisis de impacto fiscal requerido para esta medida. Además, señaló que tampoco identificó memoriales explicativos suficientes, estudios económicos, comentarios de agencias concernidas o documentación que permitiera determinar adecuadamente el efecto financiero que tendría la implantación de la propuesta sobre el Gobierno de Puerto Rico. En consecuencia, sostuvo que actualmente no existen elementos suficientes para validar que el Proyecto cumple con el principio de neutralidad fiscal contenido en el Plan Fiscal certificado.

Asimismo, la AAFAF observó que la medida podría generar nuevas obligaciones económicas para el Plan de Salud del Gobierno y para otras entidades públicas responsables de sufragar servicios de salud, sin que se identifiquen mecanismos concretos para absorber dichos costos o reprogramar recursos existentes. Por ello, expresó preocupación sobre la ausencia de estimados presupuestarios confiables que permitan determinar el alcance real de las obligaciones financieras que surgirían como resultado de la aprobación del Proyecto.

Por otro lado, reconoció que su evaluación se limita a los aspectos fiscales y presupuestarios de la medida, por lo que destacó la importancia de contar con el análisis especializado de agencias con competencia sustantiva en materia de salud y seguros médicos. En particular, recomendó considerar los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES)

y la Oficina del Procurador del Paciente, a fin de obtener una evaluación integral sobre la viabilidad clínica, operacional, regulatoria y financiera de la propuesta legislativa.

Finalmente, la AAFAF indicó que brindará deferencia al criterio técnico de las Agencias concernidas en cuanto a la conveniencia de la medida, siempre que las recomendaciones formuladas por estas sean consistentes con los parámetros fiscales establecidos por PROMESA, el Plan Fiscal certificado y el presupuesto balanceado del Gobierno de Puerto Rico. En virtud de lo anterior, concluyó que mantiene interrogantes fiscales y programáticas significativas sobre el Proyecto del Senado 1201.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

Esta Honorable Comisión recibió los comentarios de la **Administración de Seguros de Salud (ASES)**, suscrita por su Director Ejecutivo, Lcda. Carlos A. Santiago Rosario, expresándose en contra de la pieza legislativa objeto de evaluación.



En términos generales, ASES reconoció la importancia de ampliar el acceso a tratamientos innovadores que han demostrado beneficios clínicos para diversas condiciones de salud y que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. En ese contexto, explicó que su función principal consiste en administrar y negociar los beneficios del Plan Vital dentro de los parámetros establecidos por la legislación estatal y federal aplicable al Programa Medicaid. Asimismo, puntualizó que cualquier ampliación de beneficios bajo el Plan Vital requiere cumplir con estrictos requisitos federales y, en muchos casos, la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) mediante un *State Plan Amendment* (SPA), proceso que exige la evaluación detallada del impacto fiscal y operacional de la propuesta.

De igual forma, reconoció el potencial terapéutico de las células madre para atender enfermedades hematológicas, inmunológicas, cardiovasculares, neurológicas, musculoesqueléticas y autoinmunes. Sin embargo, destacó que las aplicaciones de estas terapias presentan distintos niveles de evidencia científica y desarrollo clínico, existiendo tratamientos plenamente aprobados y otros que permanecen en etapas de investigación. Además, señaló que el costo de estas terapias puede oscilar desde varios miles hasta millones de dólares, dependiendo de la condición tratada, la tecnología utilizada y la complejidad del procedimiento.

Por otra parte, ASES informó que desde el año 2023 el Plan Vital ya contempla determinadas terapias celulares mediante cubiertas especiales dirigidas a pacientes con condiciones complejas o catastróficas. En particular, indicó que actualmente se cubren trasplantes hematopoyéticos de células madre cuando resultan médicamente necesarios para ciertas condiciones oncológicas y hematológicas. Asimismo, destacó la existencia de mecanismos complementarios, como el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediabiles (FSECR), que puede asistir a pacientes cuyos tratamientos no se encuentran cubiertos bajo el formulario básico del programa.

No obstante, ASES manifestó reservas respecto al lenguaje amplio contenido en el proyecto. Específicamente, señaló que la redacción propuesta obligaría a cubrir de manera general tratamientos con células madre, terapias celulares y terapias génicas para una extensa variedad de condiciones médicas, sin delimitar adecuadamente cuáles tratamientos cuentan con aprobación regulatoria, criterios clínicos definidos o viabilidad presupuestaria. A juicio de ASES, dicha amplitud dificulta la realización de proyecciones precisas sobre el impacto fiscal de la medida y podría generar obligaciones de cobertura incompatibles con los requisitos federales aplicables al Programa Medicaid.



Aunque ASES expresó favorecer la intención legislativa de ampliar el acceso a terapias avanzadas para pacientes con condiciones graves, no avaló el lenguaje actual del Proyecto debido a sus implicaciones presupuestarias, regulatorias y operacionales. En consecuencia, recomendó evaluar con mayor precisión el alcance de la cubierta propuesta, identificar los tratamientos específicamente elegibles para cobertura y considerar los requisitos de aprobación federal necesarios antes de implantar cualquier expansión de beneficios dentro del Plan Vital.

ASES reconoció el valor clínico de las terapias con células madre y confirma que algunas ya forman parte de las cubiertas especiales del Plan Vital; sin embargo, advirtió que la medida, según redactada, carece de parámetros suficientemente definidos para determinar su impacto fiscal y su compatibilidad con las exigencias federales de Medicaid. Enfatizó en la necesidad de revisar el lenguaje de la pieza legislativa para delimitar con mayor precisión los tratamientos cubiertos, establecer criterios clínicos y regulatorios objetivos, y evaluar previamente el impacto presupuestario y los requisitos de aprobación federal mediante un *State Plan Amendment* (SPA).

OFICINA PROCURADOR DEL PACIENTE (OPP)

De igual forma, evaluamos la ponencia de la **Oficina del Procurador del Paciente**, presentada por conducto de su Procuradora, Edna I. Díaz De Jesús, expresándose a favor de la aprobación de la medida sujeto a la incorporación de enmiendas. En el desempeño de su deber ministerial de velar por los derechos de los pacientes y promover el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, la OPP sostuvo que la propuesta legislativa responde a una necesidad real de política pública relacionada con el acceso a tratamientos innovadores respaldados por evidencia científica.

La Oficina reconoció que, a pesar de los avances alcanzados en la medicina moderna, numerosos pacientes continúan enfrentando barreras económicas significativas para acceder a terapias con células madre, aun cuando estas han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y no poseen carácter experimental. Según indicó, esta situación genera desigualdades en el acceso a tratamientos especializados y limita las alternativas terapéuticas disponibles para pacientes que padecen condiciones complejas, particularmente aquellas relacionadas con enfermedades hematológicas y oncológicas.



Asimismo, la OPP destacó que las terapias con células madre constituyen uno de los campos de mayor innovación dentro de la biomedicina contemporánea. Particularmente, señaló que los trasplantes de médula ósea y de células hematopoyéticas han demostrado ser tratamientos clínicamente validados para diversas enfermedades, incluyendo ciertos tipos de cáncer sanguíneo, condiciones hematológicas y trastornos autoinmunes. A esos efectos, enfatizó que las terapias aprobadas por la FDA cuentan con sólida evidencia científica, cumplen rigurosos estándares de seguridad y calidad, y representan intervenciones que pueden salvar vidas y mejorar significativamente los resultados clínicos de los pacientes.

De igual forma, puntualizó que la medida establece salvaguardas adecuadas al limitar la cubierta exclusivamente a tratamientos aprobados por las autoridades regulatorias competentes. Según expresó, esta delimitación resulta consistente con las normas vigentes de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y contribuye a minimizar los riesgos asociados con terapias experimentales o carentes de validación científica. En consecuencia, sostuvo que la propuesta armoniza con las mejores prácticas de salud pública al promover el acceso únicamente a tratamientos cuya eficacia y seguridad han sido debidamente demostradas.

Por otro lado, la OPP advirtió que el alto costo de estas terapias continúa representando un obstáculo significativo para muchos pacientes, incluso para aquellos que cuentan con seguros privados. Más aún, observó que la cobertura actualmente disponible bajo el Plan Vital resulta limitada o inexistente en determinados casos, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos especializados para personas de escasos o moderados recursos económicos. Por ello, sostuvo que la aprobación de la medida contribuiría a promover una mayor equidad en el sistema de salud, garantizando que la capacidad económica no sea el factor determinante para recibir tratamientos potencialmente vitales.

Además, la Oficina señaló que la creación de un nuevo capítulo dentro del Código de Seguros de Salud permitiría uniformar aspectos fundamentales relacionados con la prestación de estos servicios, incluyendo los criterios de elegibilidad clínica, los procesos de referido y autorización, los requisitos aplicables a proveedores certificados y los mecanismos de supervisión y fiscalización. A su juicio, estas disposiciones fortalecerían tanto la protección de los pacientes como la sostenibilidad del sistema de salud, al garantizar que únicamente se cubran terapias seguras, reguladas y científicamente avaladas.



Finalmente, la OPP respaldó expresamente la inclusión de una cláusula que condicione la cobertura exclusivamente a terapias aprobadas por las autoridades regulatorias competentes, al entender que dicha disposición constituye una salvaguarda indispensable para proteger la seguridad de los pacientes y asegurar que los tratamientos cubiertos cuenten con eficacia comprobada y respaldo científico. En virtud de lo anterior, concluyó que el Proyecto del Senado 1201 promueve el acceso equitativo a terapias innovadoras, fortalece los derechos de los pacientes y adelanta una política pública consistente con los principios de calidad, seguridad y justicia en la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (ASEM)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Administración de Servicios Médicos (ASEM)**, suscritos por su Director Ejecutivo, Regino Colón Alsina, endosando el Proyecto del Senado 1201.

ASEM sostuvo que la propuesta atiende una necesidad clínica real y apremiante, fundamentada en décadas de evidencia científica que respaldan la eficacia de estas terapias para el tratamiento de condiciones hematológicas, oncológicas, inmunológicas y degenerativas. Destacó que, como principal institución hospitalaria pública del país y centro de referencia para casos complejos, observa diariamente cómo la ausencia de cobertura para estos tratamientos constituye una barrera significativa al acceso a servicios de salud esenciales para numerosos pacientes puertorriqueños.

Asimismo, la Administración señaló que los trasplantes de células madre hematopoyéticas constituyen una de las intervenciones médicas más ampliamente validadas en la medicina contemporánea. Particularmente, destacó, que estos procedimientos son utilizados para tratar leucemias, linfomas, mieloma múltiple, anemia aplásica, talasemia y múltiples condiciones adicionales reconocidas por las autoridades regulatorias. A esos efectos, resaltó que la creciente utilización de estos tratamientos y los resultados clínicos observados en los últimos años evidencian su consolidación como un estándar de cuidado para diversas enfermedades potencialmente mortales.



De igual forma, ASEM enfatizó los avances alcanzados en el campo de las terapias génicas basadas en células madre, destacando la aprobación reciente de tratamientos innovadores para pacientes con enfermedad de células falciformes y otras condiciones hematológicas complejas. Según indicó, estas terapias representan un cambio paradigmático en la medicina moderna al ofrecer alternativas con potencial curativo para enfermedades que históricamente han estado asociadas a una elevada morbilidad y mortalidad. Además, reconoció que los avances en tecnologías de edición genética y medicina de precisión continúan ampliando las posibilidades terapéuticas disponibles para los pacientes.

Por otro lado, puntualizó que uno de los principales méritos del Proyecto consiste en reducir la brecha existente entre la disponibilidad clínica de estos tratamientos y la capacidad económica de los pacientes para acceder a ellos. Según expresó, los costos de las terapias con células madre y de determinadas terapias génicas pueden alcanzar cifras extraordinariamente elevadas, convirtiéndose en tratamientos inaccesibles para gran parte de la población. En consecuencia, sostuvo que la cobertura obligatoria propuesta contribuiría significativamente a garantizar un acceso más equitativo a servicios de salud altamente especializados, independientemente de la condición económica de los pacientes.

De otra parte, ASEM reconoció que la medida incorpora salvaguardas regulatorias apropiadas al limitar la cubierta exclusivamente a tratamientos aprobados por la FDA o autorizados mediante protocolos clínicos regulados. Según señaló, esta delimitación evita la cobertura de procedimientos experimentales, cosméticos o carentes de evidencia científica validada, asegurando que los recursos del sistema de salud se destinen únicamente a tratamientos cuya eficacia y seguridad han sido debidamente demostradas. Además, destacó que las exclusiones contempladas en el proyecto reflejan un balance ético y regulatorio adecuado.

Igualmente, favoreció las disposiciones que prohíben discriminaciones por diagnóstico, edad o pronóstico clínico y aquellas que limitan la imposición de copagos, deducibles o costos compartidos más onerosos que los aplicables a otros tratamientos complejos. A su juicio, estas disposiciones promueven principios fundamentales de equidad en salud y fortalecen las garantías de acceso para poblaciones vulnerables que dependen de servicios especializados para preservar su vida y bienestar.



No obstante, ASEM formuló recomendaciones específicas dirigidas a fortalecer la implantación de la medida. En particular, recomendó que durante el proceso de reglamentación se incorporen mecanismos que garanticen tarifas de reembolso adecuadas para los hospitales públicos que provean estos tratamientos, incluyendo la propia institución. Asimismo, solicitó ser considerada como parte de los organismos consultivos que participen en la elaboración de la reglamentación, dado su rol como principal proveedor hospitalario público y centro de atención para una parte significativa de la población beneficiaria del Plan Vital.

Además, la institución hospitalaria sugirió fortalecer el lenguaje relacionado con los planes autoasegurados sujetos a la legislación federal ERISA. A esos efectos, advirtió que la exclusión de dichos planes podría generar diferencias importantes en el acceso a tratamientos entre distintos grupos de trabajadores. Por ello, recomendó explorar mecanismos adicionales que incentiven la adopción voluntaria de estas cubiertas por parte de los planes autoasegurados, con el propósito de minimizar posibles brechas de acceso.

Finalmente, ASEM concluyó que el Proyecto del Senado 1201 descansa sobre una sólida base científica, responde a una necesidad real de salud pública y contiene salvaguardas regulatorias suficientes para garantizar una implantación responsable. En virtud de ello,

expresó su endoso a la medida y exhortó a la Comisión de Salud a favorecer su aprobación, tomando en consideración las recomendaciones institucionales formuladas para asegurar una implementación efectiva, equitativa y sostenible en beneficio de los pacientes de Puerto Rico.

OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS (OCS)

De igual forma, evaluamos la ponencia de la **Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)**, presentada por conducto de su Comisionada, Lcda. Suzette Del Valle Lecároz, expresándose a favor de la aprobación de la medida sujeto a la incorporación de enmiendas. En ese sentido, reconoció la importancia de promover alternativas terapéuticas innovadoras y reafirmó su compromiso con iniciativas que amplíen el acceso de los pacientes a tratamientos médicos avanzados, particularmente aquellos relacionados con la medicina regenerativa.



Asimismo, destacó que la medicina regenerativa ha experimentado avances significativos en los últimos años, particularmente en el tratamiento de condiciones hematológicas, inmunológicas, oncológicas y degenerativas. No obstante, puntualizó que actualmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) únicamente ha aprobado un número limitado de terapias con células madre para condiciones específicas, mientras que una gran cantidad de tratamientos continúan siendo considerados experimentales o permanecen en etapas de evaluación clínica. Indicó que, como consecuencia, la mayoría de los planes médicos no proveen cobertura para estas terapias, trasladando a los pacientes costos que pueden ascender a miles de dólares por tratamiento.

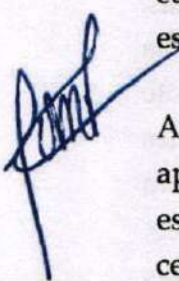
La OCS reconoció que el Proyecto atiende una problemática legítima relacionada con el acceso a tratamientos innovadores, al procurar que pacientes con condiciones complejas puedan beneficiarse de terapias que han demostrado resultados prometedores y que cuentan con aprobación regulatoria. Según señaló, la medida persigue reducir las barreras económicas que actualmente limitan el acceso a estas alternativas terapéuticas y fomentar una mayor equidad en la prestación de servicios de salud.

Sin embargo, advirtió que existen importantes consideraciones regulatorias, clínicas y actuariales que deben ser evaluadas antes de imponer una obligación generalizada de cubierta. Particularmente, señaló que muchas aseguradoras continúan clasificando gran parte de las terapias con células madre como tratamientos experimentales debido a la

ausencia de evidencia clínica suficiente sobre su efectividad a largo plazo y su relación costo-beneficio en comparación con los tratamientos convencionales.

Por otro lado, la OCS reconoció que el continuo desarrollo científico y la expansión de las aprobaciones emitidas por la FDA podrían eventualmente justificar una ampliación progresiva de las cubiertas médicas para estas terapias. En ese contexto, observó que determinados tratamientos podrían generar ahorros a largo plazo para el sistema de salud al reducir hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos de alto costo asociados a enfermedades complejas. No obstante, enfatizó que cualquier expansión de cubierta debe estar fundamentada en evidencia científica robusta y en evaluaciones económicas adecuadas.

A esos efectos, manifestó preocupación por el alcance amplio y general de la medida, particularmente en lo relacionado con la inclusión de terapias regenerativas sin criterios específicos de elegibilidad o delimitación clínica. Por ello, recomendó que el Proyecto esté acompañado de un análisis actuarial que permita determinar el impacto que la nueva cubierta tendría sobre las primas, las reservas financieras, la suficiencia tarifaria y la estabilidad del mercado de seguros de salud en Puerto Rico.



Además, la OCS recomendó que la cubierta se limite exclusivamente a tratamientos aprobados por la FDA para la condición específica del paciente y que dichos tratamientos estén sujetos a criterios de necesidad médica, autorización previa, administración en centros certificados, evaluación continua de evidencia clínica y cumplimiento con los requisitos federales aplicables. A su juicio, estas salvaguardas permitirían garantizar la seguridad de los pacientes y la utilización responsable de recursos públicos y privados destinados al cuidado de la salud.

Finalmente, la OCS concluyó que estaría en posición de respaldar el Proyecto del Senado 1201 siempre que se incorporen las recomendaciones presentadas y se consideren las observaciones adicionales que puedan formular el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina del Procurador del Paciente y otras entidades con peritaje especializado en la materia. En consecuencia, sostuvo que una política pública adecuadamente delimitada, sustentada en criterios médicos claros, evidencia científica y responsabilidad fiscal, puede contribuir significativamente a mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores sin comprometer la estabilidad financiera y operacional del mercado de seguros de salud de Puerto Rico.

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PUERTO RICO (ACODESE)

Asimismo, la **Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico (ACODESE)**, presentó su memorial explicativo por conducto de su Directora Ejecutiva, Lcda. Iraelia Pernas, expresándose en contra de la aprobación de la medida.

Aunque la organización reconoció los avances alcanzados por la medicina regenerativa y el potencial terapéutico que determinadas terapias con células madre han demostrado en el tratamiento de diversas condiciones médicas, sostuvo que la propuesta presenta preocupaciones significativas desde el punto de vista clínico, regulatorio, operacional y actuarial que requieren una evaluación más rigurosa antes de imponer un mandato de cubierta de tal magnitud.

En ese sentido, ACODESE puntualizó que su principal objeción responde a la continua expansión de cubiertas mandatorias dentro del sistema de seguros de salud sin que se examine adecuadamente el impacto acumulativo que estas obligaciones tienen sobre las primas, los costos operacionales de las aseguradoras y la sostenibilidad general del mercado. Según indicó, cada nueva cubierta obligatoria limita la flexibilidad en el diseño de beneficios y puede generar aumentos en los costos que eventualmente recaen sobre patronos, asegurados individuales y programas financiados con fondos públicos.

Asimismo, advirtió que, aunque el Proyecto condiciona la cubierta a tratamientos aprobados o autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el campo de la medicina regenerativa continúa evolucionando aceleradamente. Por ello, señaló que muchas terapias celulares y génicas permanecen sujetas a estudios clínicos continuos, autorizaciones limitadas o aprobaciones aceleradas basadas en evidencia científica todavía en desarrollo. En consecuencia, sostuvo que convertir este tipo de tratamientos en una obligación permanente de cubierta podría trasladar riesgos clínicos y financieros significativos al sistema de salud y, eventualmente, a los asegurados mediante aumentos en primas y costos compartidos.

De igual forma, ACODESE manifestó preocupación por la amplitud del lenguaje utilizado en el Proyecto, particularmente en aquellas disposiciones que prohíben excluir tratamientos con células madre, terapias celulares o terapias génicas cuando exista una certificación de necesidad médica y alguna forma de aprobación regulatoria federal. A su juicio, dicha redacción podría interpretarse de manera excesivamente amplia y abrir la puerta a reclamaciones relacionadas con una variedad extensa de terapias altamente

complejas y costosas, sin que existan parámetros clínicos claramente delimitados para determinar su aplicabilidad.

Por otro lado, destacó que la pieza legislativa no evalúa adecuadamente la capacidad real de Puerto Rico para ofrecer todas las terapias potencialmente cubiertas bajo la medida. En particular, señaló que actualmente no existe certeza de que la Isla cuente con suficientes centros especializados, infraestructura clínica adecuada o profesionales debidamente capacitados para administrar la totalidad de estos tratamientos. Como consecuencia, advirtió que la implantación de la medida podría obligar a los aseguradores a sufragar tratamientos fuera de Puerto Rico, incrementando considerablemente los costos asociados a hospitalización, transportación, coordinación de servicios y seguimiento clínico.

Además, ACODESE expresó preocupación por la ausencia de requisitos específicos relacionados con la preparación y certificación de los profesionales autorizados para administrar estas terapias. A esos efectos, recomendó que cualquier legislación sobre la materia establezca criterios mínimos de capacitación, experiencia y certificación profesional, limitando la administración de estos tratamientos a especialistas con formación acreditada en disciplinas como oncología, hematología, ortopedia o medicina física y rehabilitación, según corresponda a la condición tratada.

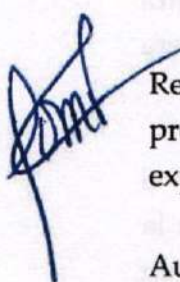
Igualmente, sostuvo que el proyecto restringe indebidamente la capacidad de los planes médicos para implementar mecanismos razonables de manejo clínico y control de utilización. Según explicó, resulta indispensable que las aseguradoras conserven la facultad de aplicar criterios de necesidad médica, procesos de preautorización y evaluaciones fundamentadas en guías clínicas reconocidas y evidencia científica actualizada, especialmente cuando se trata de terapias de alto costo y complejidad clínica significativa.

Particular preocupación mereció para ACODESE la disposición relacionada con copagos, deducibles y costos compartidos. Señaló, que las terapias celulares y génicas figuran entre los tratamientos más costosos disponibles actualmente en el mercado biomédico, pudiendo alcanzar cientos de miles e incluso millones de dólares por paciente. En consecuencia, enfatizó que resulta indispensable realizar previamente un análisis actuarial que permita determinar el efecto real que esta obligación tendría sobre las primas, la sostenibilidad del mercado de seguros y el financiamiento del Plan Vital.

Asimismo, recomendó que cualquier parámetro relacionado con deducibles, copagos o coaseguros sea calibrado conforme a los resultados de dicho análisis y que, de aprobarse la medida, su vigencia se haga efectiva al momento de la renovación de los planes existentes para permitir una adecuada incorporación del riesgo actuarial correspondiente.

Finalmente, ACODESE concluyó que, aunque el Proyecto del Senado 1201 persigue un propósito legítimo relacionado con el acceso a tratamientos innovadores, establece una obligación de cubierta excesivamente amplia y potencialmente onerosa sin contar con parámetros clínicos, regulatorios y actuariales suficientemente definidos para garantizar una implantación responsable. Por consiguiente, expresó que no favorece la aprobación de la medida en su redacción actual y recomendó que cualquier consideración futura incorpore salvaguardas regulatorias, criterios clínicos específicos y estudios actuariales que permitan evaluar adecuadamente su impacto sobre el sistema de salud y el mercado de seguros de Puerto Rico.

PLAN DE SALUD MENONITA, INC. (PSM)



Recibimos, de igual forma, la ponencia del **Plan de Salud Menonita, Inc. (PSM)** presentado por conducto de su Principal Asesora Legal, Lcda. Yamilca Ortiz Carrión, expresándose en contra de la aprobación de la medida.

Aunque la entidad reconoció el valor científico y el potencial terapéutico de estas modalidades de tratamiento para pacientes con condiciones hematológicas, inmunológicas, oncológicas y degenerativas complejas, sostuvo que una política pública responsable debe distinguir entre el reconocimiento de sus beneficios clínicos y la imposición de un mandato legislativo amplio, inmediato y financieramente indeterminado.

En ese sentido, PSM argumentó que la medida presenta serias deficiencias actuariales, operacionales y regulatorias que impiden respaldar su aprobación en la forma propuesta. Particularmente, señaló que el Proyecto impone una cubierta obligatoria sin estar acompañado de un estudio actuarial o fiscal que permita evaluar adecuadamente su impacto sobre las primas, las reservas financieras, los costos administrativos y la sostenibilidad del sistema de salud. A esos efectos, destacó que las terapias avanzadas con células madre suelen implicar costos extraordinariamente elevados, incluyendo hospitalización especializada, procesamiento celular, medicamentos inmunosupresores

y seguimiento clínico prolongado, pudiendo alcanzar cientos de miles de dólares e incluso superar el millón de dólares por paciente.

Asimismo, puntualizó que el lenguaje de la pieza legislativa objeto de evaluación resulta excesivamente amplio y ambiguo, ya que algunas disposiciones extienden la cubierta a terapias autorizadas mediante protocolos clínicos regulados o a tratamientos cuya necesidad médica sea certificada por un profesional de la salud. PSM es de la opinión que dicha redacción genera incertidumbre respecto a cuáles terapias estarían cubiertas, cuáles serían los estándares de evidencia clínica aplicables, cómo se atenderían los usos experimentales o fuera de etiqueta y qué criterios uniformes se utilizarían para determinar la necesidad médica y la costo-efectividad de los tratamientos.

De igual forma, la aseguradora sostuvo que el Proyecto limita indebidamente herramientas esenciales de manejo clínico y administración de utilización, tales como los procesos de preautorización, revisión por pares, validación de indicaciones aprobadas y evaluación de necesidad médica. Según explicó, estos mecanismos no constituyen barreras arbitrarias al acceso a servicios, sino instrumentos indispensables para garantizar que tratamientos altamente complejos y costosos sean utilizados de manera segura, apropiada y basada en evidencia científica.

Por otro lado, PSM expresó preocupación respecto a la interacción de la medida con el marco regulatorio federal, particularmente con los planes autoasegurados sujetos a la legislación ERISA. La entidad señaló que la exclusión de dichos planes podría generar un escenario regulatorio fragmentado, afectando la competitividad entre aseguradoras y comprometiendo el objetivo de equidad que persigue la medida.

Igualmente, destacó que el acceso efectivo a terapias avanzadas depende de una infraestructura especializada que incluye hospitales, laboratorios acreditados, redes clínicas subespecializadas y protocolos rigurosos de seguimiento. En consecuencia, sostuvo que imponer una obligación legal de cubierta sin desarrollar simultáneamente dichos componentes operacionales podría generar expectativas públicas que resultarían difíciles de satisfacer de manera uniforme y sostenible.

Finalmente, Plan de Salud Menonita recomendó que, de continuarse la discusión de esta materia, se adopte un enfoque escalonado y técnicamente delimitado que incluya la realización de un estudio actuarial independiente previo a cualquier implantación y la

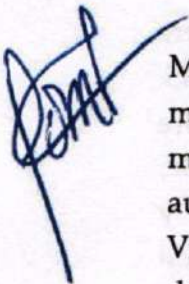
Comisión de Salud
Informe Negativo del Proyecto del Senado 1201

delegación a la Oficina del Comisionado de Seguros y al Departamento de Salud de la elaboración de reglamentación técnica especializada antes de imponer obligaciones compulsorias de cubierta.

En virtud de todo lo anterior, concluyó que el Proyecto del Senado 1201 no debe ser aprobado en su redacción actual, al entender que carece de las salvaguardas regulatorias, actuariales y operacionales necesarias para garantizar una implantación ordenada, sostenible y compatible con la estabilidad financiera del sistema de salud de Puerto Rico.

MMM HOLDINGS, INC.

MMM Holdings, Inc. y MMM Multihealth (MMM) presentó su memorial explicativo suscrito por su Director Senior de Relaciones con Gobierno, Comunidad y Asuntos Públicos, Jonathan A. Bonet Rivera, y de su Director Médico Corporativo, Diego E. Ross Flores, expresando ciertas preocupaciones sobre la medida objeto de evaluación.



MMM expresó su respaldo al propósito fundamental del Proyecto del Senado 1201, medida que procura ampliar el acceso a terapias avanzadas de medicina regenerativa mediante la inclusión de tratamientos con células madre debidamente aprobados por las autoridades regulatorias federales dentro de las cubiertas de salud, incluyendo el Plan Vital. Resaltó que la propuesta constituye una iniciativa dirigida a fortalecer los derechos de los pacientes que enfrentan condiciones hematológicas, inmunológicas, oncológicas, degenerativas y otras enfermedades complejas, promoviendo alternativas terapéuticas respaldadas por evidencia científica y criterios regulatorios rigurosos.

En ese contexto, MMM destacó su compromiso con la prestación de servicios de salud de excelencia y con el acceso a tratamientos innovadores para poblaciones vulnerables, particularmente aquellas atendidas bajo programas financiados con fondos públicos. Asimismo, reconoció que la medida persigue una política pública legítima orientada a garantizar que los pacientes tengan acceso a opciones terapéuticas acordes con sus necesidades clínicas cuando estas hayan demostrado efectividad y seguridad mediante los procesos regulatorios correspondientes.

No obstante, puntualizó que la discusión legislativa debe considerar cuidadosamente los distintos marcos regulatorios que gobiernan los programas de salud existentes. En particular, señaló que cualquier análisis relacionado con el impacto financiero y operacional de la medida sobre el Plan Vital debe deferirse a la Administración de

Seguros de Salud (ASES), por ser la entidad responsable de administrar el programa y poseer la información actuarial, demográfica y de utilización necesaria para evaluar adecuadamente las implicaciones de la propuesta.

De igual forma, MMM advirtió que el Proyecto del Senado 1201 presenta importantes retos en cuanto a su posible aplicación al programa federal Medicare Advantage. A esos efectos, explicó que dicho programa opera bajo un marco normativo exclusivamente federal y se encuentra sujeto a las determinaciones del *Centers for Medicare & Medicaid Services* (CMS), por lo que las legislaturas estatales y territoriales carecen de facultad para imponer requisitos adicionales de cubierta que excedan los parámetros establecidos por la legislación federal. Según indicó, la jurisprudencia federal ha reiterado consistentemente que las disposiciones relacionadas con Medicare Advantage están sujetas a un régimen de ocupación de campo federal, salvo en asuntos relacionados con licenciamiento y solvencia de las aseguradoras.



Asimismo, explicó que actualmente Medicare únicamente reconoce y cubre determinadas terapias con células madre bajo criterios específicos establecidos por CMS. Entre ellas se encuentran ciertos trasplantes alogénicos y autólogos de células madre hematopoyéticas para condiciones como síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple, mielofibrosis y anemia drepanocítica, sujetos a protocolos de evidencia clínica y supervisión regulatoria. En contraste, señaló que Medicare no cubre tratamientos con células madre para enfermedades degenerativas, ortopédicas, autoinmunes ni terapias relacionadas con plasma rico en plaquetas, debido a la ausencia de aprobación regulatoria para dichas aplicaciones.

Por otro lado, MMM reconoció que los programas Medicaid y Plan Vital sí constituyen espacios donde la Asamblea Legislativa puede evaluar mecanismos para ampliar el acceso a tratamientos avanzados. En ese sentido, destacó que Medicaid ya contempla cobertura para determinados trasplantes de células madre hematopoyéticas y para terapias CAR-T cuando estas sean médicamente necesarias y se realicen en centros certificados. Sin embargo, enfatizó la necesidad de examinar cuidadosamente la capacidad del sistema de salud para absorber una expansión obligatoria de estas cubiertas.

A esos efectos, recomendó que la Comisión examine con detenimiento varios elementos esenciales antes de adoptar una política pública definitiva. Entre estos, destacó la

necesidad de evaluar la disponibilidad de infraestructura clínica especializada, laboratorios acreditados y personal médico con experiencia en medicina regenerativa, hematología, oncología y trasplantes celulares. Igualmente, propuso solicitar la posición oficial de ASES respecto al impacto financiero que la medida podría generar sobre el Plan Vital y definir con mayor precisión el rol del Departamento de Salud, ASES y las agencias fiscalizadoras en los procesos de autorización, supervisión y cumplimiento regulatorio contemplados por el proyecto.

Finalmente, MMM reiteró su compromiso con el acceso a servicios de salud de alta calidad y expresó su respaldo a la intención de la medida de ampliar alternativas terapéuticas para los pacientes. No obstante, enfatizó la importancia de que cualquier expansión de cubiertas relacionadas con terapias de células madre se realice de forma coordinada con las autoridades regulatorias competentes, tomando en consideración las limitaciones jurisdiccionales federales, la capacidad operacional del sistema de salud y el impacto financiero que la implantación de la medida podría representar para los programas públicos de salud en Puerto Rico.



SOCIEDAD AMERICANA CONTRA EL CÁNCER DE PUERTO RICO

Finalmente, la **Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico** presentó su memorial explicativo suscrito por su Vicepresidenta de Asuntos Públicos y Servicios a Pacientes, Lcda. Maria Cristy, expresándose a favor de la aprobación de la medida. La entidad destacó que representa a cerca de 26,000 pacientes en tratamiento activo contra el cáncer en Puerto Rico y que su misión institucional se centra en promover políticas públicas dirigidas a la prevención, tratamiento y reducción del impacto de esta enfermedad.

Señaló, que la investigación y aplicación terapéutica de las células madre constituye uno de los avances más significativos de la medicina moderna, debido a su capacidad regenerativa y su potencial para reparar tejidos y órganos afectados por diversas condiciones de salud. Asimismo, explicó que estas terapias han permitido transformar el tratamiento de enfermedades complejas como la leucemia, el linfoma, la anemia aplásica, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 1 y las lesiones de médula espinal, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los resultados clínicos.

De igual manera, puntualizó que las células madre han promovido el desarrollo de

tratamientos más personalizados y efectivos, adaptados a las características particulares de cada paciente. Según expuso, esta modalidad terapéutica no solo incrementa la efectividad de las intervenciones médicas, sino que también reduce la incidencia de complicaciones y efectos adversos, lo que eventualmente genera ahorros sustanciales para el sistema de salud al disminuir la necesidad de tratamientos inefectivos o repetitivos.

Particularmente en el ámbito oncológico, reconoció que las terapias con células madre han representado una herramienta fundamental en el tratamiento de cánceres hematológicos como la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. A esos efectos, destacó que el trasplante de médula ósea constituye uno de los usos más exitosos de esta tecnología, ya que permite reconstruir el sistema sanguíneo e inmunológico de los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, reduciendo complicaciones asociadas al tratamiento y mejorando sustancialmente las probabilidades de recuperación.



No obstante, la Sociedad recomendó aclarar en el Proyecto que la vigencia y efectividad de la Ley no quedará condicionada a la promulgación de reglamentación por parte de las agencias concernidas, debido a que experiencias previas han demostrado que la ausencia de reglamentos puede impedir la implementación efectiva de legislación ya aprobada. Además, sugirió que el término de ciento ochenta (180) días concedido para la adopción de la reglamentación correspondiente sea de estricto cumplimiento, a fin de garantizar la pronta ejecución de la política pública propuesta.

Finalmente, la Sociedad Americana Contra el Cáncer concluyó que el uso de células madre representa una alternativa terapéutica revolucionaria que ha demostrado su capacidad para salvar vidas, reducir complicaciones médicas y ampliar las oportunidades de tratamiento para pacientes con condiciones graves, particularmente aquellos diagnosticados con cáncer. Por consiguiente, expresó su respaldo total al Proyecto del Senado 1201, al entender que la medida promoverá un acceso más equitativo a tratamientos innovadores, mejorará los resultados clínicos de los pacientes y generará ahorros significativos a largo plazo para el sistema de salud de Puerto Rico.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Ley 1-2023, realizó una evaluación del impacto fiscal

potencial del Proyecto del Senado 1201 con el propósito de determinar las implicaciones presupuestarias derivadas de la ampliación de las cubiertas obligatorias de los planes médicos en Puerto Rico. El Informe rendido fue suscrito por su Director Ejecutivo, Lcdo. Hecrian D. Martínez Martínez.

En su análisis, la entidad legislativa expuso que la medida propuso imponer a todos los aseguradores de salud, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital), la obligación de cubrir tratamientos clínicos con células madre, terapias celulares y terapias génicas que hayan recibido aprobación o autorización de las autoridades regulatorias federales y que, además, estén sustentados por una determinación de necesidad médica.



Del mismo modo, explicó que la legislación incorporó un nuevo capítulo al Código de Seguro de Salud de Puerto Rico para establecer el marco regulatorio aplicable a estas terapias, definir los tratamientos comprendidos dentro de la cubierta obligatoria, delimitar las exclusiones permitidas y garantizar que las aseguradoras no puedan denegar dichos tratamientos por su naturaleza regenerativa cuando estos cuenten con el aval científico y regulatorio correspondiente. Igualmente, OPAL destacó que la medida procuró asegurar la equidad en el acceso a estas terapias mediante la prohibición de discrimen, la limitación de copagos y deducibles excesivos y la obligación impuesta a la Oficina del Comisionado de Seguros, al Departamento de Salud, a la Administración de Seguros de Salud y a la Oficina del Procurador del Paciente de adoptar la reglamentación necesaria para su implantación uniforme.

En cuanto al análisis económico de la propuesta, la OPAL señaló que la incorporación obligatoria de estas terapias representa un potencial aumento en las obligaciones financieras tanto del Plan de Salud del Gobierno como de las aseguradoras privadas, toda vez que las terapias celulares y génicas constituyen algunos de los tratamientos más especializados y costosos actualmente disponibles en la práctica médica.

En apoyo de dicha conclusión, la Oficina hizo referencia a estudios científicos que evidencian que los trasplantes de células madre hematopoyéticas pueden representar costos superiores a los cien mil dólares en procedimientos autólogos y sobrepasar los doscientos mil dólares en trasplantes alogénicos, mientras que el costo acumulado de la atención médica de un paciente sometido a este tipo de tratamiento puede alcanzar cifras cercanas a un millón de dólares o más. Asimismo, resaltó OPAL que la Administración de Seguros de Salud administró un presupuesto consolidado que supera los cinco mil

millones de dólares, financiado predominantemente con fondos federales, y que el Plan Vital brinda cobertura a cerca de 1.37 millones de beneficiarios, circunstancias que reflejan la magnitud del impacto que podría generar la incorporación de nuevas cubiertas obligatorias dentro del programa gubernamental de salud.

No obstante, la OPAL puntualizó que la información disponible no permite cuantificar con certeza el costo fiscal de la medida, debido a que dicho ejercicio requiere un análisis actuarial especializado que considere variables como la frecuencia de utilización de estas terapias, la incidencia de las condiciones médicas elegibles, el costo de los procedimientos, la hospitalización, los medicamentos, los laboratorios especializados y los servicios clínicos complementarios. De igual forma, enfatizó que cualquier impacto económico sobre el Plan Vital dependerá, en gran medida, de la determinación que adopten los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) respecto a la aprobación de las modificaciones al Plan Estatal y a la disponibilidad de financiamiento federal para sufragar estos beneficios.



HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La evaluación integral del Proyecto del Senado 1201 demuestra que, si bien la medida responde al propósito legítimo de ampliar el acceso a terapias con células madre para pacientes que padecen enfermedades complejas, la prueba documental incorporada al expediente legislativo no sostiene que la propuesta, en su redacción actual, reúna los elementos jurídicos, regulatorios, fiscales y operacionales indispensables para su implantación. La Comisión reconoce que la medicina regenerativa constituye uno de los campos de mayor desarrollo dentro de la medicina contemporánea y que determinadas terapias con células madre aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) han demostrado beneficios clínicos importantes. Sin embargo, la función legislativa exige que toda expansión de derechos y beneficios dentro del sistema de salud vaya acompañada de un análisis responsable sobre su viabilidad jurídica, administrativa y financiera.

Precisamente, la mayor parte de las Agencias con competencia técnica que comparecieron durante el proceso legislativo coincidieron en expresar reservas sustanciales respecto a la medida. El Departamento de Salud advirtió que la amplitud del Proyecto impide determinar con precisión su impacto económico y operacional. Asimismo, puntualizó que cualquier modificación al Plan Vital requiere cumplir con las disposiciones federales aplicables al Programa Medicaid, incluyendo la presentación y aprobación *del State Plan*

Amendment ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), requisito que no se encuentra debidamente desarrollado dentro de limpieza legislativa objeto de evaluación.

De igual forma, la Administración de Seguros de Salud sostuvo que, aunque reconoce el valor clínico de determinadas terapias con células madre y confirmó que algunas ya forman parte de las cubiertas especiales del Plan Vital, la medida propone una obligación de cubierta excesivamente amplia, sin delimitar con precisión cuáles tratamientos serían elegibles, cuáles responderían a indicaciones aprobadas por la FDA y cuáles continuarían siendo considerados experimentales o sujetos a investigación clínica. Tal carencia imposibilita realizar proyecciones actuariales confiables y podría imponer obligaciones incompatibles con el marco regulatorio federal.



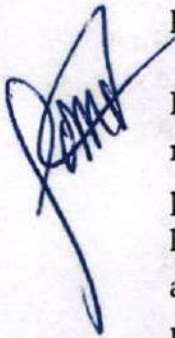
A estas preocupaciones se suman las observaciones formuladas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la cual destacó que el expediente legislativo carece de un análisis de impacto fiscal que permita determinar la compatibilidad de la medida con la Ley PROMESA, el Plan Fiscal certificado y el principio de presupuesto balanceado. La ausencia de estudios económicos, proyecciones presupuestarias y fuentes específicas de financiamiento impide concluir que el Gobierno de Puerto Rico posee la capacidad fiscal para asumir una obligación cuya magnitud permanece indeterminada.

Del mismo modo, la Comisión concede particular relevancia a las observaciones formuladas por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la cual concluyó que el efecto fiscal del Proyecto del Senado 1201 permanece indeterminado debido a la ausencia de información actuarial, clínica y presupuestaria suficiente para cuantificar el costo real de la medida. En su evaluación, OPAL reconoció que la propuesta persigue ampliar el acceso a terapias innovadoras mediante la incorporación de tratamientos con células madre, terapias celulares y terapias génicas como cubiertas obligatorias; sin embargo, advirtió que estas intervenciones constituyen algunos de los procedimientos médicos de mayor costo dentro de la medicina contemporánea.

Asimismo, destacó que la implantación de la medida podría representar un aumento significativo en las obligaciones financieras del Plan Vital y de las aseguradoras privadas, sin que el expediente legislativo contenga estudios especializados que permitan proyectar la frecuencia de utilización, la población potencialmente beneficiaria, el costo de los procedimientos, la hospitalización, los medicamentos especializados ni los

servicios clínicos complementarios. De igual forma, señaló que cualquier impacto económico dependerá de la determinación que adopte CMS respecto a la aprobación de las modificaciones al Plan Estatal y a la disponibilidad de fondos federales para sufragar dichos beneficios. Tendiendo esto presente, esta Comisión coincide con OPAL en que la ausencia de un análisis actuarial y presupuestario confiable impide validar la sostenibilidad financiera de la medida y constituye un impedimento significativo para recomendar su aprobación en esta etapa del proceso legislativo.

Por otra parte, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico y el Plan de Salud Menonita coincidieron en su advertencia de que la medida no incorpora los parámetros regulatorios necesarios para preservar la estabilidad del mercado de seguros de salud. Asimismo, destacaron que el Proyecto restringe mecanismos indispensables de manejo clínico, tales como la autorización previa, la revisión de necesidad médica y la evaluación basada en evidencia científica.



Igualmente, la Comisión considera particularmente significativas las preocupaciones relacionadas con la capacidad operacional del sistema de salud para implantar la política pública propuesta. Del expediente legislativo surge que Puerto Rico aún enfrenta limitaciones en cuanto a infraestructura especializada, disponibilidad de centros acreditados y personal altamente capacitado para administrar la totalidad de las terapias potencialmente cubiertas por la medida.

Por todo lo anterior, esta Comisión concluye que, si bien la intención de ampliar el acceso a terapias innovadoras constituye un objetivo loable, dicho propósito debe armonizarse con los principios de responsabilidad fiscal, seguridad jurídica, evidencia científica y viabilidad administrativa. En consecuencia, la Comisión entiende indispensable que cualquier propuesta debe delimitar expresamente las terapias sujetas a cobertura, incorporar criterios clínicos objetivos y uniformes, garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios federales, incluir estudios actuariales y fiscales independientes que cuantifiquen el impacto económico de la lo propuesto y establezca mecanismos reglamentarios que aseguren una implantación ordenada y sostenible.

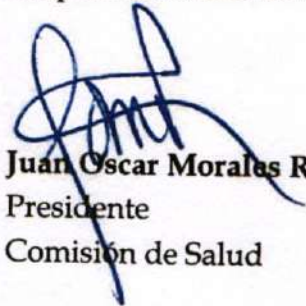
De lo contrario, se podrían generar obligaciones económicas indeterminadas, conflictos regulatorios con el Programa Medicaid, incertidumbre para el mercado de seguros de salud y dificultades operacionales para el sistema sanitario de Puerto Rico. Por ello, cónsono con las posiciones esbozadas por las agencias y entidades con competencia

especializada en materia fiscal, regulatoria y administrativa, esta Comisión no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1201, por entender que la medida, en su redacción actual, no ofrece las garantías necesarias para asegurar una implantación jurídicamente adecuada, fiscalmente responsable y operacionalmente viable.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, Negativo, **NO RECOMENDANDO LA APROBACIÓN del Proyecto del Senado 1201.**

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud